

26/11
16h

PAULO CESAR DE SOUZA - Comerciante	
MEDICAMENTOS:	
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS - sonolência - Artralgia
BANHEIRO	4 à 5x / noite
HORA QUE ACORDA	6
HORA QUE DORME	21 IAH = 36/h
PRATICA EXERCICIO	Tem necrose de cabeça de fêmur
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE: sim	ALMOÇO: sim LANCHE: sim JANTA: sim
20/09	P = 6,5 cm H ₂ O
22	IAH = 6,2/h SpO₂ m = 93% SpO₂ b = 81%
27/09	P = 6,5 cm H ₂ O
22	IAH = 0,6/h Fuga: 17.1 l/min
	M. de uso: 4h 55'
	Bem adaptado fuo
11/10	P = 6,6 cm H ₂ O
22	IAH = 0,3/h
	M. de uso: 6h 50'
	Bem adaptado, relata melhora fuo
10/11	P = 6,6 cm H ₂ O
22	IAH = 0,5 l/min
	M. de uso: 6h 50'
	Bem adaptado, relata melhora da sonolência, cansaço, mas não está fazendo exerc. fuo
12/01	P = 6,6 cm
23	IAH = 0,3 l/h
	M. de uso: 5h
	Bem adaptado, teve herpes zoster. fuo
23/03	P = 6,6 cm H ₂ O
23	M. de uso: 6h 12'
	IAH = 0,4 e/h
	Fuga = 22.4 l/min
	Bem adaptado, 3 queixas. fuo
28/06	P = 6,6 cm H ₂ O
23	IAH = 0,4 e/h
	M. de uso: 6h 50'
	Fuga = 18.8 l/min
	Bem adaptado

SP 62958

CAMENTOS:			
TOMAS/QUEIXAS			
ANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME			
PRATICA EXERCICIO			
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
20/09	P = 6.6 cmH ₂ O		
23	IAH = 0.3 e/ev		
	M. de uso: 6h35'		Jua Cláudio
21/11	P = 6.6 cmH ₂ O		
23	IAH = 0.4 e/ev		
	M. de uso: 7h		Jua.
	Fuga = 10.6 l/min		
30/01	P = 6.6 cmH ₂ O		
24	M. de uso: 7h		
	IAH = 0.4		
	Fuga = 21.1 l/min.		Jua.
03/04	P = 6.6 cmH ₂ O		
24	M. de uso: 7h 49m		
	IAH = 0.9 e/ev		
	Fuga: 19 l/min		
		Bem adaptado	
		foi liberado p/ realizar	
		ativ. fisica	
			Natasha
13/06	P = 6.6 cmH ₂ O		
24	IAH = 1.0		
	M. de uso: 8h05'		
	Fuga = 17.3 lpm		Jua Cláudio
28/08/24	P = 6.6 cmH ₂ O		
	IAH = 0.7 e/ev		
	Fuga = 16 l/min		
	M. de uso: 7h50 min.		
		Bem adaptado	
		* troco filtro *	
			Silvia
07/11	P = 6.6 cmH ₂ O		
24	IAH = 0.6 e/ev		
	M. de uso: 6h17'		
	Fuga = 15 lpm.		
		Bem adaptada.	
			Jua
26/02/25	P = 6.6 cmH ₂ O		
	IAH = 0.6 e/ev		
	M. de uso: 5h36 min		
	Fuga = 13 l/min		
		* troco prong de com wear	
		(M)	
			Silvia
24/07/25	P = 6.6 cmH ₂ O		
	IAH = 0.7 e/ev		
	M. de uso: 7h24'		
	Fuga = 18.1		
			Jua Cláudio



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Paulo César de Souza
EXAME nº: 5127-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 03/08/2022
IDADE: 58 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h31min e concluído às 06h39min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 60 minutos. O tempo total de sono foi de 446,5 (07h26min) minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,5%. A distribuição do sono mostrou 10% de estágio 1, 46,6% de estágio 2, 19,8% de estágio 3 e 23,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 33,5 minutos em vigília, ocorreram 111 microdespertares (índice: 14,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 6,2/hora, sendo 0 apneia/hora e 6,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 6,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, a média de 93% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (6,2/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (6,2/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 51; máxima: 70 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h30min. A latência para o estágio REM estava encurtada (60 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (91,5%; normal: 85% ou acima) e o índice microdespertares (14,9/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (19,8%; normal: 10-12%) e REM (23,6%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 1 (10%; normal: 8-10%) e 2 (46,6%; normal: 45-55%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNESP
Doutor em Ciências pela UNESP
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO L.
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Paulo César de Souza
EXAME nº: 5127
SOLICITADO POR: Dra. Natália Carmona Cardoso
DATA: 20/05/2022
IDADE: 57 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h55min e concluído às 06h16min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o estágio REM, de 142 minutos. O tempo total de sono foi de 386,5 (06h26min) minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 78,1%. A distribuição do sono mostrou 13,2% de estágio 1, 45,8% de estágio 2, 23,7% de estágio 3 e 17,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 97 minutos em vigília, ocorreram 128 microdespertares (índice: 19,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 36/hora, sendo 3,4 apneia/hora e 32,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 36/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, a média de 92% e a mínima de 87%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (36/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (36/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 62 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (142 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 78,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 19,9/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (13,2%; normal: 8-10%) e 3 (23,7%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (17,3%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (45,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 3 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNFESP
CRM-SP: 69.730

DRa. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Paulo César de Souza

Solicito o aluguel/venda do CPAP
para o tratamento da síndrome da apnéia
do sono.

Ele usou a máscara nasal Mirage Active
large (Resmed®).

Pressão recomendada baseado na
polissonografia com o CPAP: 6,5 cm H₂O

Att,


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

STC, 12/9/22

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730